

순천향대학교 천안병원

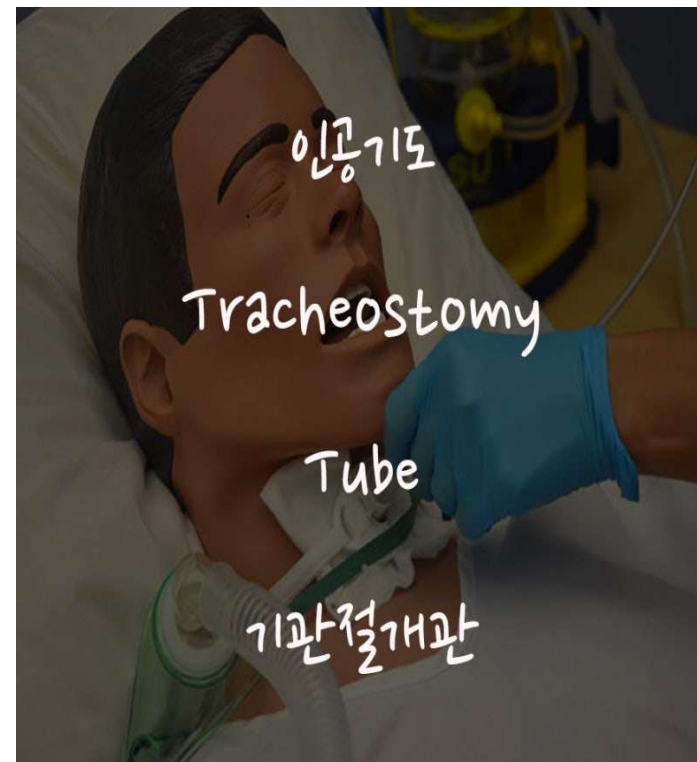
진료 지원 간호팀

찾아가는 교육

DATE
2026.08.01

PRESENTER
박소이 계장

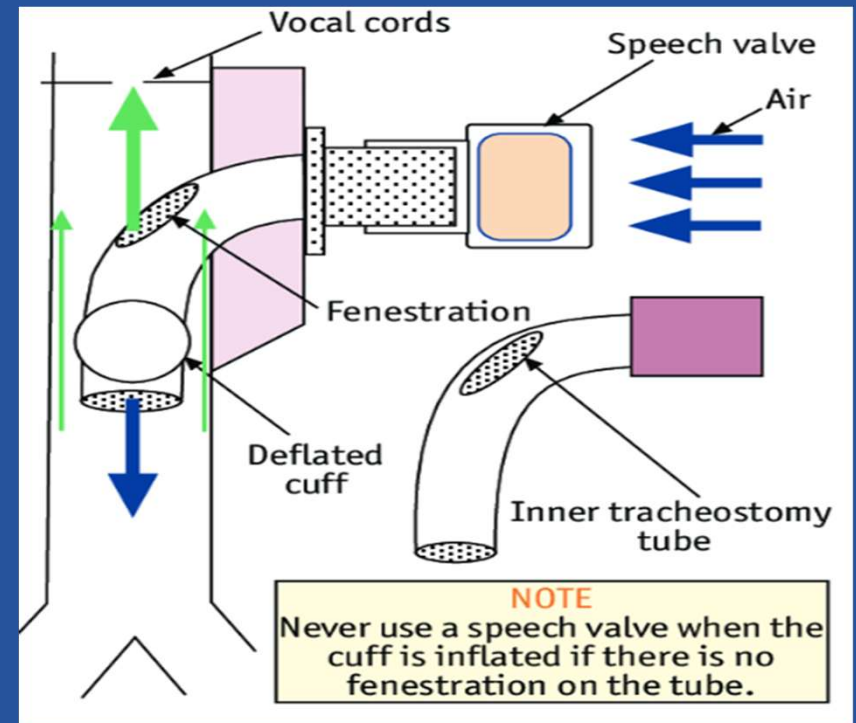
SCHMC · SOONCHUNHYANG UNIVERSITY CHEONAN HOSPITAL



SCH
순천향대학교
천안병원

Tracoe tube 구조

01

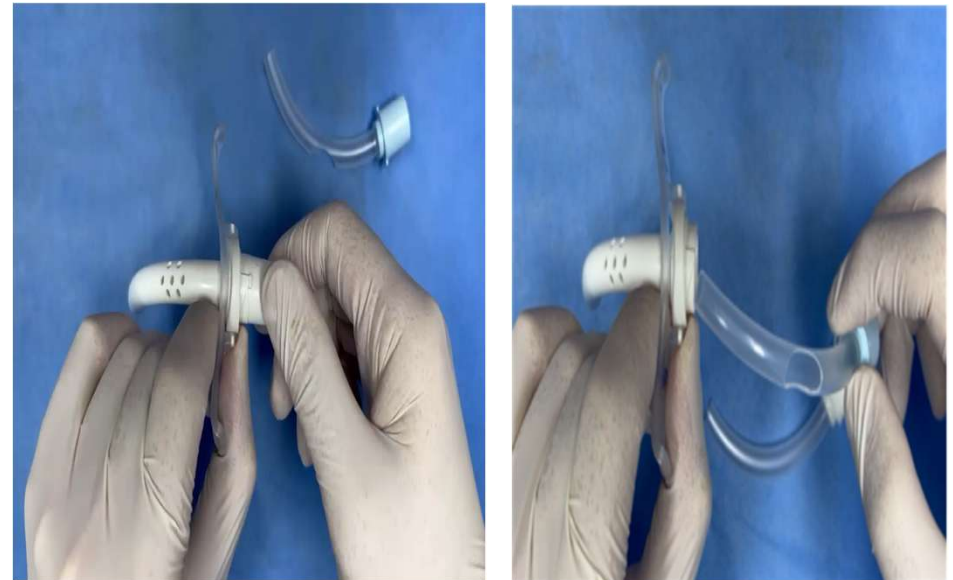


Tracoe tube 내관 교체하는 방법

02

내관 교체 시 기존 내관을 시계 반대 방향으로 90도 돌린 후
뺀 후 다른 내관을 교체한다.

내관을 교체 후 시계방향으로 90도 돌리면서 고정한다.



기관절개술 환자 튜브 교환 시 준비물품

03

교환할 기관절개관 (동일크기의 기관 절개관)

및 교환할 튜브 보다 한 단계 작은 기관절개관

Endo tracheal tube(No.5)

ENT I&D set

10cc 주사기. 에픽신(연고)

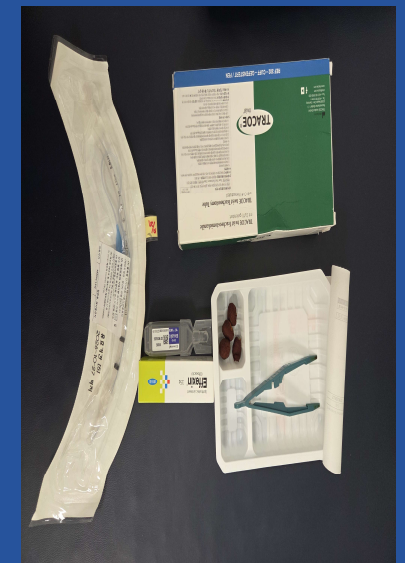
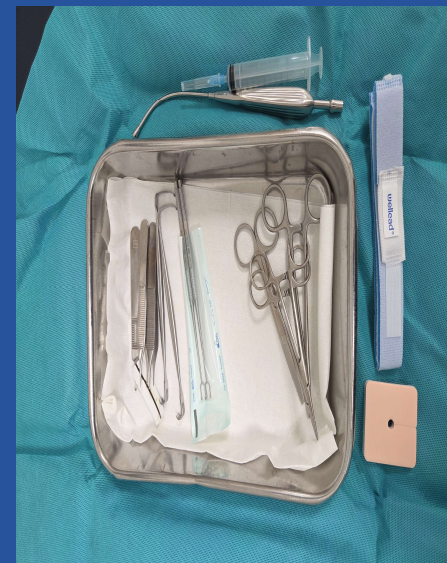
Soft tracheal tube holder

흡인기. 앰부백, 산소 공급 장비

Y 폼 가드

Saline, 베타딘 볼

ENT I&D set(Incision & Drainage set)



기관절개술 환자 드레싱시 준비물품

04

D-set (기본 드레싱 세트)

Forceps
Betadine ball
Y form Guard
Gauze



기관절개술 환자 수술 후 간호

05

기도 유지 - 기관절개관 위치 확인, 기도 개방성 유지

흡인- 필요시 무균적으로 시행. 10~ 15초 이내

가슴 - 가슴 산소 공급으로 점액 마개 예방

분비물 관찰- 양,색,점도. 냄새 확인

호흡 사정- 호흡수, SPO2, 호흡음, 청색증 지속 관찰

응급 상황- 기관절개관 폐쇄, 이탈, 산소포화도 저하 시 즉시 대응 및 보고

환자 및 보호자 교육- 기관절개관 관리, 흡인 방법, 절개 부위 관리, 응급 상황 대처법, 퇴원 후 자가 관리 방법 교육

기관절개술 환자 수술 후 간호

06

- 수술 후 조직 손상의 예방을 위해 커프 14-20mmHg 로 유지
- 수술 후 pneumothorax 및 subcutaneous emphysema 확인 위해 목까지 올려서 chest AP 촬영
- 침상은 과신전 금기, 과 굴곡 금지 (Head elevation 30도 유지)
- 침상 절대 안정
- Ballooning: 2시간마다 deballoon 유지 (10분간)
- 내관 소독 : 최초 6시간 동안은 1시간마다, 그 이후 2시간마다 12시간동안 하며, 이후 4시간마다 해서 수술 후 72시간 소독한다
- 바세린 거즈 48시간(2일 후) 제거하며 Neck CT 촬영

THANK YOU

END OF DOCUMENT

감사합니다